Marketing farmaceutických firiem a predpisovanie liekov: čo ukázal Cochranov prehľad

Autor: MUDr. Ľubomír Polaščín · Publikované: 05.11.2026



Ilustračná poloschematická scéna. Nejde o zobrazenie konkrétnej situácie, osoby ani spoločnosti.

Dňa 9. októbra 2026 vyšla v Cochranovej databáze aktualizácia systematického prehľadu o tom, ako informačné a propagačné aktivity farmaceutických spoločností pôsobia na predpisujúcich lekárov. Zahŕňa 93 štúdií a jej záver je jednoznačný: propagačné interakcie s farmaceutickými spoločnosťami sú pravdepodobne spojené s nepriaznivými dôsledkami, teda s menej vhodným predpisovaním, väčším množstvom predpísaných liekov a vyššími nákladmi.

Prehľad má zároveň dve vlastnosti, ktoré sa pri citovaní pravidelne strácajú a bez ktorých sa jeho výsledky vykladajú nesprávne. Po prvé, pre heterogenitu nebolo možné urobiť žiadnu metaanalýzu; ide o naratívnu syntézu. Po druhé, 88 % zaradených štúdií pochádza zo Spojených štátov. Prenos týchto zistení do slovenského prostredia preto vyžaduje osobitnú úvahu, a to tým skôr, že Slovensko má vlastný zákonný register plnení, o ktorom sa hovorí prekvapivo málo.

Čo prehľad hodnotil

Autori prehľadávali databázy CENTRAL, MEDLINE, Embase, jednu ďalšiu databázu a dva registre klinických skúšaní do januára 2025. Zaradili randomizované aj nerandomizované štúdie, kontrolované štúdie pred intervenciou a po nej, prerušované časové rady a prierezové, kohortové a prípadovo-kontrolné štúdie, pokiaľ údaje pokrývali celú populáciu alebo náhodnú vzorku definovanej populácie s mierou odpovede najmenej 60 %.

Kritickými výstupmi boli vhodnosť predpisovania, množstvo predpísaných liekov, náklady na predpisovanie a žiadosti o zaradenie lieku do nemocničného zoznamu. Expozície boli rozdelené do štyroch skupín: reklama a vzdelávanie, dary a platby, bezplatné vzorky a politiky riadenia konfliktu záujmov.

Dôveryhodnosť dôkazov hodnotili metodikou GRADE. Znížili ju pre riziko skreslenia a nepresnosť, a zvýšili ju pre **vzťah dávky a odpovede a veľký rozsah účinku**. Ten druhý bod je dôležitý: práve existencia stúpajúceho

gradientu medzi mierou expozície a mierou zmeny predpisovania je argument, ktorý samotný pozorovací dizajn posilňuje.

Zloženie dôkazovej základne

Z 93 štúdií bolo 82 (88 %) zo Spojených štátov a 11 z Európskej únie alebo Spojeného kráľovstva. Z hľadiska dizajnu bolo 60 prierezových, 23 kontrolovaných kohortových, štyri kontrolované pred intervenciou a po nej, štyri prerušované časové rady, jedna vnorená prípadovo-kontrolná štúdia a **jediná randomizovaná kontrolovaná štúdia**, ktorej oba výstupy boli navyše vyhodnotené ako celkovo vysoko rizikové z hľadiska skreslenia.

Hlavnou metodickou výhradou pri prierezových a kohortových štúdiách bola identifikácia konfundujúcich faktorov. Prehľad teda nie je dôkazom príčinnej súvislosti a jeho autori to formulujú opatrne slovom „pravdepodobne“.

Výsledky podľa typu expozície

Expozícia	Vhodnosť predpisovania	Množstvo	Náklady
Dary a platby	znížená (10 štúdií; 2 941 948 predpisujúcich)	zvýšené (39 štúdií; 3 858 871)	pravdepodobne zvýšené (25 štúdií; 2 505 292)
Reklama a vzdelávanie	môže byť znížená (6 štúdií; 1 335)	pravdepodobne zvýšené (7 štúdií; 151 399)	môžu byť zvýšené (2 štúdie; 986)
Bezplatné vzorky	veľmi neisté (1 štúdia; 10 praxí)	veľmi neisté (4 štúdie; 150 050)	veľmi neisté (4 štúdie; 2 508)
Politiky konfliktu záujmov	pravdepodobne zlepšená (2 štúdie; 3 065)	môže byť znížené (6 štúdií; 110 470)	neisté (2 štúdie; 33 975)

Formulácie v tabuľke nie sú štylistická variácia. Zodpovedajú stupňom istoty podľa metodiky GRADE: „je spojené“ znamená vyššiu istotu než „pravdepodobne je spojené“, a to zase vyššiu než „môže byť spojené“ a „veľmi neisté“. Najsilnejší signál je teda pri daroch a platbách, kde je znížená vhodnosť predpisovania a zvýšené množstvo doložené bez zmierňujúceho slova.

Pri žiadostiach o zaradenie lieku do nemocničného zoznamu bolo dôkazov málo, jedna štúdia so 105 predpisujúcimi. Reklama, vzdelávanie, dary a platby môžu byť spojené s vyšším počtom takýchto žiadostí, ale dôkaz je veľmi neistý.

Mimoriadne poučná je skupina bezplatných vzoriek. Práve tá sa v bežnom uvažovaní považuje za najnevinnejšiu formu kontaktu, a práve pri nej je dôkaz najslabší. Jedna štúdia o desiatich praxiach nedokáže povedať nič. Neistota tu však nie je to isté ako dôkaz neškodnosti; znamená, že otázka zostáva otvorená.

Politiky konfliktu záujmov pôsobia opačným smerom

Osem štúdií skúmalo inštitucionálne politiky, napríklad obmedzenie návštev obchodných zástupcov alebo zákaz prijímania darov a vzoriek. Tieto obmedzenia sú pravdepodobne spojené s lepšou vhodnosťou predpisovania a môžu byť spojené s nižším množstvom predpísaných liekov; vplyv na náklady zostáva neistý.

Ide o najpraktickejšiu časť celého prehľadu, pretože na rozdiel od expozície je politika pracoviska niečo, čo sa dá rozhodnutím zmeniť. Autori prehľadu neuvádzajú žiadne financovanie.

Slovenský kontext: register, o ktorom sa málo vie

Osemdesiatosem percent dôkazov pochádza z amerického prostredia, ktoré sa od slovenského líši podstatne. V Európskej únii je reklama liekov viazaných na lekársky predpis určená širokej verejnosti zakázaná, takže celá vetva priamej spotrebiteľskej reklamy, ktorá americké predpisovanie spoluformuje, tu odpadá.

Zároveň platí, že Slovensko má vlastnú zákonnú obdobu amerického registra platieb, a to už roky. Podľa **§ 15 ods. 1 písm. u) zákona č. 362/2011 Z. z.** o liekoch a zdravotníckych pomôckach je držiteľ povolenia na výrobu liekov povinný predkladať v elektronickej podobe Národnému centru zdravotníckych informácií, a to

výslovne „na účely verejnej kontroly poskytovania peňažných alebo nepeňažných plnení“, najneskôr do 31. januára a 31. júla kalendárneho roka správu o výdavkoch na propagáciu, marketing a na peňažné a nepeňažné plnenia za predchádzajúci kalendárny polrok.

Obsah správy je podrobný. Podľa § 15 ods. 8 sa výdavky člena na marketing, propagáciu lieku, peňažné plnenia a nepeňažné plnenia poskytnuté priamo alebo nepriamo zdravotníckemu pracovníkovi alebo poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti. Podľa ods. 9 sa pri plneniach uvádza meno, priezvisko a zdravotnícke povolanie pracovníka, názov a adresa zdravotníckeho zariadenia, výška a účel plnenia a pri plnení viazanom na liek aj názov lieku alebo jeho anatomicko-terapeuticko-chemickej skupiny, s členením účelu na klinické skúšanie, neintervenčnú klinickú štúdiu, štúdiu o bezpečnosti po registrácii, prieskum trhu, odborné prednášky, odborné konzultácie, účastnícke a registračné poplatky a dary.

Zákon pamätá aj na nepriame cesty. Podľa ods. 11 a 12 je pri plnení poskytnutom cez tretiu osobu nutné oznámiť aj identifikáciu tejto tretej osoby, a samotná tretia osoba musí držiteľovi povolenia do 30 dní oznámiť zoznam príjemcov.

Podľa § 15 ods. 13 Národné centrum zdravotníckych informácií bezodkladne zverejní oznámené údaje na svojom webovom sídle. Ak zdravotnícky pracovník alebo poskytovateľ zistí, že zverejnené informácie o jeho osobe nie sú presné, úplné alebo pravdivé, môže podať námietku; centrum o nej rozhodne do 30 dní.

Z toho vyplýva praktická možnosť, ktorú väčšina lekárov nevyužíva: **údaje o vlastnej osobe sú verejné a dajú sa skontrolovať**. Nejde o obvinenie ani o vyzvanie k pocitu viny. Ide o to, že dáta, ktoré Cochranov prehľad analyzoval v americkom prostredí, sú u nás k dispozícii na úrovni jednotlivca a dajú sa použiť na vlastnú kontrolu.

Prečo je téma relevantná práve v nefrológii

Nefrológia má niekoľko vlastností, pre ktoré je na tento typ vplyvu nadpriemerne citlivá.

- **Dlhodobé predpisovanie.** Rozhodnutie o lieku pri chronickej chorobe obličiek sa často nerobí na mesiac, ale na roky. Raz zavedená preferencia sa reprodukuje pri každej ďalšej kontrole a pri každom ďalšom pacientovi.
- **Viacero blízko rovnocenných možností.** Pri viazačoch fosfátov, látkach stimulujúcich erytropoézu, inhibítoroch HIF-prolylhydroxylázy, kalcimimetikách aj v rámci tried inhibítorov SGLT2 existuje viacero prípravkov s podobným postavením v odporúčaniach. Práve tam, kde odborný podklad nerozhoduje jednoznačne, má propagácia najviac priestoru.
- **Vysoká cena.** Viaceré z týchto skupín patria k nákladovo najvýznamnejším v medicíne vôbec, takže aj malý posun v predpisovaní má veľký rozpočtový dosah.
- **Rozhodovanie na úrovni protokolu.** V dialyzačnom stredisku sa značná časť liečby neriadi receptom pre jednotlivého pacienta, ale liečebným protokolom alebo zoznamom liekov pracoviska. Výstup „žiadosti o zaradenie lieku do zoznamu“, pre ktorý má Cochranov prehľad najmenej dôkazov, je práve ten, ktorý je v dialýze najvýznamnejší. Vplyv na jedného človeka, ktorý protokol pripravuje, sa prenesie na všetkých pacientov strediska naraz.

Treba povedať aj to, čo z prehľadu nevyplýva. Žiadna z 93 štúdií nehodnotila nefrológov osobitne. Tvrdenie, že nefrologické predpisovanie je ovplyvnené v rovnakej miere, by bolo extrapoláciou, nie zistením. Mechanizmus však nie je špecializačne viazaný a nie je dôvod predpokladať, že nefrológovia sú voči nemu odolnejší než ostatní.

Čo sa s tým dá urobiť na pracovisku

Najlepšie podloženou intervenciou je politika pracoviska, nie individuálne predsavzatie. Zmyslom nie je nulový kontakt s priemyslom za každú cenu, ale aby kontakt neformoval liečebné rozhodnutia tam, kde na to nemá odborný podklad.

1. Mať písomné pravidlá pre návštevy obchodných zástupcov, pre prijímanie darov a pohostenia a pre účasť na podujatiach financovaných výrobcom.
2. Pri tvorbe liečebných protokolov a zoznamov liekov vyžadovať deklaráciu konfliktu záujmov od každého, kto sa na nich podieľa, a zdokumentovať ju.

3. Pri zaraďovaní nového lieku vychádzať z odporúčaní a systematických prehľadov, nie z materiálov získaných v propagačnom kontexte; informácie z takého kontextu overiť v nezávislom zdroji.
4. Raz za čas si pozrieť vlastný záznam vo verejných údajoch zverejnených Národným centrom zdravotníckych informácií a overiť, či zodpovedá skutočnosti. Prípadnú nepresnosť rieši námietka podľa § 15 ods. 13.
5. Pri odbornom vzdelávaní rozlišovať, kto podujatie financuje a kto určuje jeho odborný program. Financovanie samo osebe nie je diskvalifikujúce; nepriznané financovanie a vplyv na obsah sú.

Záver

Najsilnejší signál z 93 štúdií sa týka darov a platieb: sú spojené s menej vhodným predpisovaním a s väčším množstvom predpísaných liekov a pravdepodobne aj s vyššími nákladmi. Inštitucionálne politiky, ktoré tieto interakcie obmedzujú, pôsobia opačne.

Dôkaz je pozorovací, prevažne americký a bez metaanalýzy. Zároveň je konzistentný naprieč desiatkami štúdií a miliónmi predpisujúcich a vykazuje vzťah dávky a odpovede. To je typ dôkazovej štruktúry, pri ktorej je rozumné konať preventívne a neodkladať opatrenia do času, keď bude k dispozícii dôkaz, ktorý z etických dôvodov pravdepodobne nikdy nevznikne.

Upozornenie: *Text je určený zdravotníckym pracovníkom a informovaným čitateľom. Neobsahuje tvrdenia o konkrétnych osobách, pracoviskách ani spoločnostiach. Uvedené zákonné ustanovenia boli overené v znení účinnom v čase publikovania; pred praktickým použitím overte aktuálne znenie na portáli Slov-Lex. Text nie je právnym stanoviskom.*

Literatúra

1. Mintzes Barbara, Lexchin Joel, Grundy Quinn, Fabbri Alice, Spurling Geoffrey K. P., Qureshi Riaz, Bero Lisa. Pharmaceutical industry information and promotional strategies aimed at prescribers. Cochrane Database of Systematic Reviews. 2026;10(10):CD013423. DOI: 10.1002/14651858.CD013423.pub3. PubMed PMID 42849912. PMC13649351, voľný plný text.

2. Zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 15 ods. 1 písm. u) a ods. 8, 9, 11, 12 a 13. Slov-Lex.

Poznámka k dôkazom

Všetky počty štúdií a predpisujúcich, formulácie stupňov istoty podľa metodiky GRADE, zloženie dôkazovej základne podľa krajín a dizajnov a údaj o chýbajúcej metaanalýze pochádzajú zo štruktúrovaného abstraktu primárneho prehľadu v PubMed, nie zo sekundárnych prevzatí. Autorský zoznam, ročník, číslo a DOI boli nezávisle overené v databáze Crossref a v PubMed. Znenie § 15 zákona č. 362/2011 Z. z. bolo overené doslovne v konsolidovanom znení stiahnutom z portálu Slov-Lex; citované sú odseky 1 písm. u), 8, 9, 11, 12 a 13.

Vlastným prínosom tohto spracovania je upozornenie na to, že prehľad neobsahuje žiadnu metaanalýzu a že 88 % jeho dôkazovej základne je americkej, zachovanie presných stupňov istoty GRADE namiesto ich zjednotenia, doplnenie slovenskej zákonnej úpravy verejného registra plnení vrátane práva na námietku, a rozbor dôvodov, pre ktoré je nefrológia na tento typ vplyvu nadpriemerne citlivá, najmä cez rozhodovanie na úrovni liečebného protokolu v dialyzačnom stredisku. Tieto súvislosti nie sú obsiahnuté v primárnom prehľade.

Súvisiace články

- Postmarketingové bezpečnostné zlyhania liekov
- Inhibítory SGLT2: rozdiely v schválených indikáciách
- Železo a anémia pri chronickej chorobe obličiek

Zdroj: https://nefro.polascin.net/article.php?slug=farmaceuticky-marketing-predpisovanie-liekov-nefrologia · Nefro-projekt Slovensko. Obsah má informačný a vzdelávací charakter a nenahrádza konzultáciu s lekárom.